Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Pose d'aérateurs transtympaniques / Myringotomie

Pose de petits tubes (yoyos) dans le tympan / ouverture du tympan pour évacuer le liquide (paracentèse)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Côté : ☐ Droit ☐ Gauche ☐ Les deux

Intervention prévue :
☐ Myringotomie + aérateur transtympanique
☐ Myringotomie seule (sans aérateur)

Type d'aérateur :
☐ Aérateur de courte durée (yoyo)
☐ Aérateur de longue durée (tube en T, etc.) _____

Actes supplémentaires au cours de la même intervention : ☐ Adénoïdectomie ☐ Amygdalectomie ☐ Aucun _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

L'oreille moyenne est une petite cavité située derrière le tympan, normalement remplie d'air. Elle est ventilée par la **trompe d'Eustache**, qui s'ouvre à l'arrière du nez. Lorsque la trompe d'Eustache fonctionne mal (en particulier chez l'enfant, en raison de végétations hypertrophiées, d'une allergie ou de rhumes fréquents), du **liquide s'accumule** dans l'oreille moyenne (« otite séromuqueuse »).

Ce liquide peut entraîner une **baisse de l'audition** et, chez l'enfant, un **retard du développement de la parole et du langage**, des troubles de l'attention, des troubles de l'équilibre et des **otites à répétition**. Si le liquide persiste longtemps, le tympan peut s'amincir, se rétracter et subir des modifications définitives. Des problèmes similaires peuvent survenir chez l'adulte, par exemple après des vols en avion ou de la plongée, ou en raison d'affections situées à l'arrière du nez.

Le but de cette intervention est de pratiquer une petite ouverture dans le tympan pour évacuer le liquide et, grâce à un petit tube placé dans cette ouverture, de maintenir la ventilation de l'oreille moyenne — **afin d'améliorer l'audition et de réduire la fréquence des infections.**

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

Chez l'enfant, l'intervention est généralement réalisée sous une courte anesthésie générale ; chez l'adulte, elle se fait le plus souvent sous anesthésie locale. Elle est réalisée par le conduit auditif, sous microscope ; **il n'y a aucune incision ni cicatrice à l'extérieur.**

1. **Nettoyage du conduit auditif :** Sous microscope, le cérumen éventuellement présent dans le conduit auditif est retiré et le tympan est examiné.
2. **Myringotomie :** Une petite incision d'environ 1–2 mm est pratiquée dans une zone du tympan où elle n'affectera pas l'audition.
3. **Évacuation du liquide :** Le liquide de l'oreille moyenne (qui peut être clair, épais et collant, ou infecté) est retiré par une fine aspiration. Si nécessaire, un prélèvement peut être réalisé pour une mise en culture.
4. **Mise en place de l'aérateur :** Un minuscule tube en forme de bobine, de quelques millimètres, est placé dans l'ouverture. Ce tube prend temporairement le relais de la trompe d'Eustache et maintient la ventilation de l'oreille moyenne.
5. **Fin de l'intervention :** Des gouttes auriculaires sont appliquées si nécessaire. En général, aucune mèche n'est placée dans l'oreille, ou seulement un petit morceau de coton.

Les **aérateurs de courte durée** sont généralement expulsés naturellement en **6–18 mois**, à mesure que le tympan cicatrise, et tombent dans le conduit auditif ; cela passe souvent inaperçu. Les **aérateurs de longue durée** restent en place plus longtemps et doivent parfois être retirés lors d'une intervention distincte.

Lorsqu'une myringotomie seule est réalisée (sans aérateur), l'ouverture du tympan se referme en quelques jours et le liquide peut s'accumuler à nouveau.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale chez l'enfant ; généralement anesthésie locale chez l'adulte	Environ 10–20 minutes pour les deux oreilles	Généralement retour à domicile le jour même

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- L'audition s'améliore généralement immédiatement ou en peu de temps
- Chez l'enfant, un effet positif sur la parole, le développement du langage, l'attention et les résultats scolaires
- Des otites moins fréquentes et moins sévères ; lorsqu'une infection survient, elle peut généralement être traitée par des gouttes auriculaires plutôt que par des antibiotiques par voie orale
- Un risque plus faible de lésions définitives du tympan ; la disparition de la sensation de pression et d'oreille bouchée

Tant que l'aérateur est en place et perméable, l'audition s'améliore et les otites deviennent moins fréquentes chez la grande majorité des patients. Si la trompe d'Eustache a suffisamment mûri au moment où l'aérateur tombe, le liquide ne revient généralement pas. Cependant, chez certains enfants (environ **20–30 sur 100**), le liquide s'accumule à nouveau et la **pose de nouveaux aérateurs** peut être nécessaire.

4 Autres options thérapeutiques

- **Surveillance :** Le liquide de l'oreille moyenne disparaît de lui-même en 3 mois chez de nombreux enfants. Si la baisse d'audition est légère et qu'il n'existe pas de facteur de risque, une surveillance avec des tests auditifs réguliers est possible.
- **Auto-insufflation :** En particulier chez les enfants plus âgés, gonfler un ballon spécial avec le nez peut aider à ouvrir la trompe d'Eustache.
- **Appareils auditifs :** Pour les patients qui ne souhaitent pas d'opération ou pour qui elle n'est pas adaptée, ils peuvent constituer une solution temporaire tant que le liquide persiste.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Médicaments :** Une allergie ou une maladie du nez et des sinus est traitée si elle est présente ; cependant, les preuves que les antibiotiques, les corticoïdes ou les sprays nasaux font disparaître durablement le liquide de l'oreille moyenne sont limitées.
- **Adénoïdectomie :** Chez certains enfants, elle peut être recommandée en même temps que la pose d'aérateurs ou lorsque de nouveaux aérateurs sont nécessaires.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Sans intervention, le liquide peut disparaître de lui-même chez certains patients ; s'il persiste, cependant, la baisse de l'audition, le retard de développement de la parole et du langage chez l'enfant, les troubles de l'attention et les difficultés scolaires, les troubles de l'équilibre et les otites à répétition peuvent se poursuivre. Un liquide qui persiste longtemps peut entraîner une rétraction du tympan, des modifications définitives du tympan, des lésions des osselets de l'audition et, rarement, des maladies de l'oreille plus graves nécessitant une opération, comme un **cholestéatome**.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Un test auditif (audiométrie) et un test de pression de l'oreille moyenne (tympanométrie) sont réalisés avant l'intervention.
- Si une anesthésie générale est prévue, vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste ; aucun aliment solide ni lait ne doit être donné pendant les **6 heures** précédant l'opération, et pour les liquides clairs, respectez le délai indiqué par le médecin anesthésiste.
- Merci de nous signaler toute fièvre, toux ou grippe dans les 2 semaines précédant l'intervention ; elle peut être reportée.
- En cas d'écoulement de l'oreille ou d'infection active, un traitement peut être nécessaire avant l'intervention.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Jour de l'intervention	La plupart des patients rentrent chez eux en quelques heures. Une légère douleur d'oreille ou une sensation d'oreille pleine peut survenir ; elle cède avec des antalgiques simples. Un écoulement légèrement teinté de sang ou aqueux peut s'écouler de l'oreille pendant quelques jours. La plupart des patients **entendent immédiatement les sons plus forts** ; cela peut sembler désagréable au début.
1re semaine	Des gouttes auriculaires sont utilisées si votre médecin les a recommandées. Les enfants peuvent retourner à l'école ou à la crèche, et les adultes au travail, en 1–2 jours. Veillez à éviter que de l'eau ne pénètre dans les oreilles.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4e–8e semaine	Le premier examen de contrôle est réalisé ; nous vérifions que l'aérateur est en place et perméable, et le test auditif est répété.
Tant que l'aérateur est en place (6–18 mois)	Des contrôles environ **tous les 3–6 mois** sont recommandés. Une otite se manifeste par un écoulement et est généralement traitée par des gouttes auriculaires. Les voyages en avion sont généralement plus confortables tant qu'un aérateur est en place.
Après la chute de l'aérateur	Le tympan est examiné pour vérifier que l'orifice s'est refermé et qu'il n'y a pas de liquide dans l'oreille moyenne ; un test auditif est réalisé.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Légère douleur d'oreille et sensation d'oreille pleine (1–2 jours)
- Écoulement de l'oreille légèrement teinté de sang ou aqueux pendant quelques jours
- Sons paraissant temporairement très forts ou résonnants
- Nausées ou agitation temporaires après une anesthésie générale

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Écoulement de l'oreille (otorrhée)** — Environ **10–25 patients sur 100** porteurs d'aérateurs présentent au moins un épisode d'écoulement de l'oreille, généralement après un rhume ou une entrée d'eau dans l'oreille. Il disparaît le plus souvent en quelques jours avec des gouttes auriculaires antibiotiques. Rarement, l'écoulement peut être persistant et nécessiter un traitement par voie orale, un nettoyage de l'oreille ou le retrait de l'aérateur.
- **Plaques blanches sur le tympan (tympanosclérose)** — Des plaques blanches d'aspect crayeux sur le tympan sont fréquentes (environ **10–30+ oreilles sur 100**). Dans la plupart des cas, elles n'affectent pas l'audition.
- **Expulsion précoce ou obstruction de l'aérateur** — L'aérateur peut tomber plus tôt que prévu ou se boucher avec du sang séché ou des sécrétions. On tente alors de le déboucher avec des gouttes ; si nécessaire, l'aérateur est remplacé.
- **Nécessité de nouveaux aérateurs** — Si le liquide s'accumule à nouveau après la chute de l'aérateur, environ **20–30 enfants sur 100** peuvent avoir besoin d'une deuxième pose d'aérateurs (parfois associée à une ablation des végétations adénoïdes).

Situations peu fréquentes

- **Trou définitif dans le tympan (perforation)** — Après la chute de l'aérateur, l'orifice du tympan peut ne pas se refermer : chez environ **1–3 patients sur 100** avec des aérateurs de courte durée, et plus souvent avec des aérateurs de longue durée (environ **10–20 sur 100**). Les petites perforations ne posent souvent aucun problème ; si elles entraînent des écoulements à répétition ou une baisse de l'audition, une **fermeture par une opération distincte (tympanoplastie/myringoplastie)** peut être nécessaire.
- **Amincissement ou rétraction du tympan** — Le tympan peut s'amincir ou se rétracter vers l'intérieur à l'endroit où se trouvait l'aérateur ; un suivi peut être nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Aérateur qui ne tombe pas** — Si l'aérateur ne tombe pas dans le délai prévu (généralement s'il reste en place plus de 2–3 ans), il peut être nécessaire de le retirer lors d'une courte intervention ; chez l'enfant, celle-ci est généralement réalisée sous anesthésie générale.
- **Prolifération de tissu dans le conduit auditif (granulome inflammatoire)** — Un tissu rouge et inflammatoire peut se former autour de l'aérateur ; il peut provoquer un écoulement teinté de sang et est traité par des gouttes ou par un petit geste.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Passage de l'aérateur dans l'oreille moyenne** — Très rarement, au lieu de tomber vers l'extérieur, l'aérateur peut glisser derrière le tympan, dans l'oreille moyenne ; une intervention distincte peut être nécessaire pour le retirer.
- **Cholestéatome** — Affection ressemblant à un kyste, due à la croissance de la couche cutanée du tympan vers l'oreille moyenne. Elle est **très rarement** associée à la pose d'aérateurs. Si elle se développe, un traitement chirurgical est nécessaire.
- **Perte d'audition, bourdonnements d'oreille (acouphènes) ou vertiges** — Une perte d'audition, des acouphènes ou des vertiges définitifs dus à une atteinte de l'oreille interne ou des osselets sont **extrêmement rares**.
- **Blessure du conduit auditif et saignement** — De petites blessures peuvent survenir dans les conduits auditifs étroits ; très rarement, des lésions graves liées à des variations anatomiques du nerf facial, de l'oreille interne ou de gros vaisseaux sanguins ont été rapportées.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Quand nous contacter immédiatement

- Écoulement de l'oreille abondant ou malodorant persistant **plus de 3–5 jours** malgré les gouttes
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, douleur d'oreille intense
- Rougeur ou gonflement derrière l'oreille, ou pavillon de l'oreille repoussé vers l'avant
- **Perte d'audition soudaine**, vertiges intenses, troubles de l'équilibre ou vomissements
- Asymétrie du visage, affaissement du coin de la bouche ou impossibilité de fermer l'œil
- Saignement abondant de l'oreille

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Tant que l'aérateur est en place, **évitez que de l'eau sale (lacs, mer, piscines, eau du bain) ne pénètre dans l'oreille.** Un coton enduit de vaseline ou des bouchons d'oreille peuvent être utilisés sous la douche et dans le bain. Suivez les conseils de votre médecin concernant la natation ; la nage en surface avec des bouchons d'oreille et/ou un bonnet de bain est généralement autorisée, mais la plongée est déconseillée.
- Ne nettoyez pas l'intérieur du conduit auditif avec des cotons-tiges.
- En cas d'écoulement de l'oreille, essuyez-le délicatement de l'extérieur, utilisez les gouttes qui vous ont été recommandées et prévenez votre médecin. N'utilisez pas d'autres gouttes auriculaires de vous-même ; certaines gouttes ne conviennent pas à l'oreille moyenne.
- Continuez à vous présenter aux rendez-vous de suivi même après la chute de l'aérateur ; il est important de surveiller l'audition et l'état du tympan.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Je comprends que l'aérateur tombera de lui-même au bout d'un certain temps, que de nouveaux aérateurs peuvent être nécessaires si le liquide s'accumule à nouveau, et que si un trou définitif persiste dans le tympan, une opération distincte peut être nécessaire pour le refermer.

☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**

☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.